

Escala breve de Trastorno de Juego por Internet

IGDS9-SF

Nombre

Fecha

Aplicado por

PARA QUÉ SIRVE

Tamizar el trastorno de juego por internet (videojuegos) con nueve preguntas, una por cada criterio propuesto en el DSM-5, referidas a los últimos doce meses. Da un puntaje de gravedad y un conteo de criterios.

CÓMO SE APLICA

1. La persona la responde sola, pensando en su actividad con los videojuegos durante el último año. Esta versión trata de «tú».
2. Se suman las nueve respuestas (9 a 45): a mayor puntaje, mayor gravedad.
3. Además se cuentan los criterios cumplidos: las preguntas respondidas «A menudo» o «Muy a menudo». Cinco o más indican posible trastorno; cuatro, riesgo.

Los siguientes ítems hacen referencia a tu actividad con los videojuegos durante el último año (es decir, los últimos 12 meses). Por actividad en los videojuegos entendemos cualquier acción relacionada con los mismos (jugar desde un ordenador/portátil o desde una videoconsola) o desde cualquier otro tipo de dispositivo (por ejemplo, teléfono móvil, tablet, etc.) tanto conectado a Internet como sin estarlo y a cualquier tipo de juego

Preguntas	Nunca	Raramente	Ocasionalmente	A menudo	Muy a menudo
1. ¿Te sientes preocupado por tu comportamiento con el juego? (Algunos ejemplos: ¿Piensas en exceso cuando no estás jugando o anticipas en exceso a la próxima sesión de juego?, ¿Crees que el juego se ha convertido en la actividad dominante en tu vida diaria?)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
2. ¿Sientes irritabilidad, ansiedad o incluso tristeza cuando intentas reducir o detener tu actividad de juego?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
3. ¿Sientes la necesidad de pasar cada vez más tiempo jugando para lograr satisfacción o placer?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
4. ¿Fallas sistemáticamente al intentar controlar o terminar tu actividad de juego?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
5. ¿Has perdido intereses en aficiones anteriores y otras actividades de entretenimiento como resultado de tu compromiso con el juego?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
6. ¿Has continuado jugando a pesar de saber que te estaba causando problemas con otras personas? (pareja, amistad o familia)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
7. ¿Has engañado a alguno de tus familiares, terapeutas o amigos sobre el tiempo que pasas jugando?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
8. ¿Juegas para escapar temporalmente o aliviar un estado de ánimo negativo (por ejemplo, desesperanza, tristeza, culpa o ansiedad)?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
9. ¿Has comprometido o perdido una relación importante, un trabajo o una oportunidad educativa debido a tu actividad de juego?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

Puntaje total (9 a 45)

Criterios cumplidos (0 a 9)

Interpretación

Escala breve de Trastorno de Juego por Internet (continuación)

Calificación e interpretación (validación española)

Medida	Qué indica
Puntaje total	De 9 a 45. A mayor puntaje, mayor gravedad de los síntomas y más problemas asociados al juego.
Criterios cumplidos	Se cuenta cada pregunta respondida «A menudo» (4) o «Muy a menudo» (5).
5 o más criterios	Posible trastorno de juego por internet, según la pauta del DSM-5 que sigue la validación: confirme con entrevista clínica.
4 criterios	En riesgo.

La versión se validó con 535 estudiantes de formación profesional de España (edad media de 18 años) que habían jugado en el último año. El artículo no reporta un punto de corte para el puntaje total.

FUENTE Y PERMISO DE USO

Pontes, H. M. y Griffiths, M. D. (2015). Measuring DSM-5 Internet Gaming Disorder: Development and validation of a short psychometric scale. *Computers in Human Behavior*, 45, 137–143 · Versión española: Beranuy, M., Machimbarrena, J. M., Vega-Osés, M. A., Carbonell, X., Griffiths, M. D., Pontes, H. M. y González-Cabrera, J. (2020). Spanish validation of the Internet Gaming Disorder Scale–Short Form (IGDS9-SF): Prevalence and relationship with online gambling and quality of life. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(5), 1562, apéndice A.
<https://doi.org/10.3390/ijerph17051562> Artículo de acceso abierto con licencia Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY), que permite reproducir la escala citando la fuente.